GUÍA DE ANTICONCEPTIVOS

Anticonceptivos *en Chile*

Marcas equivalentes, hormonas, ventajas, desventajas y riesgos de cada método.

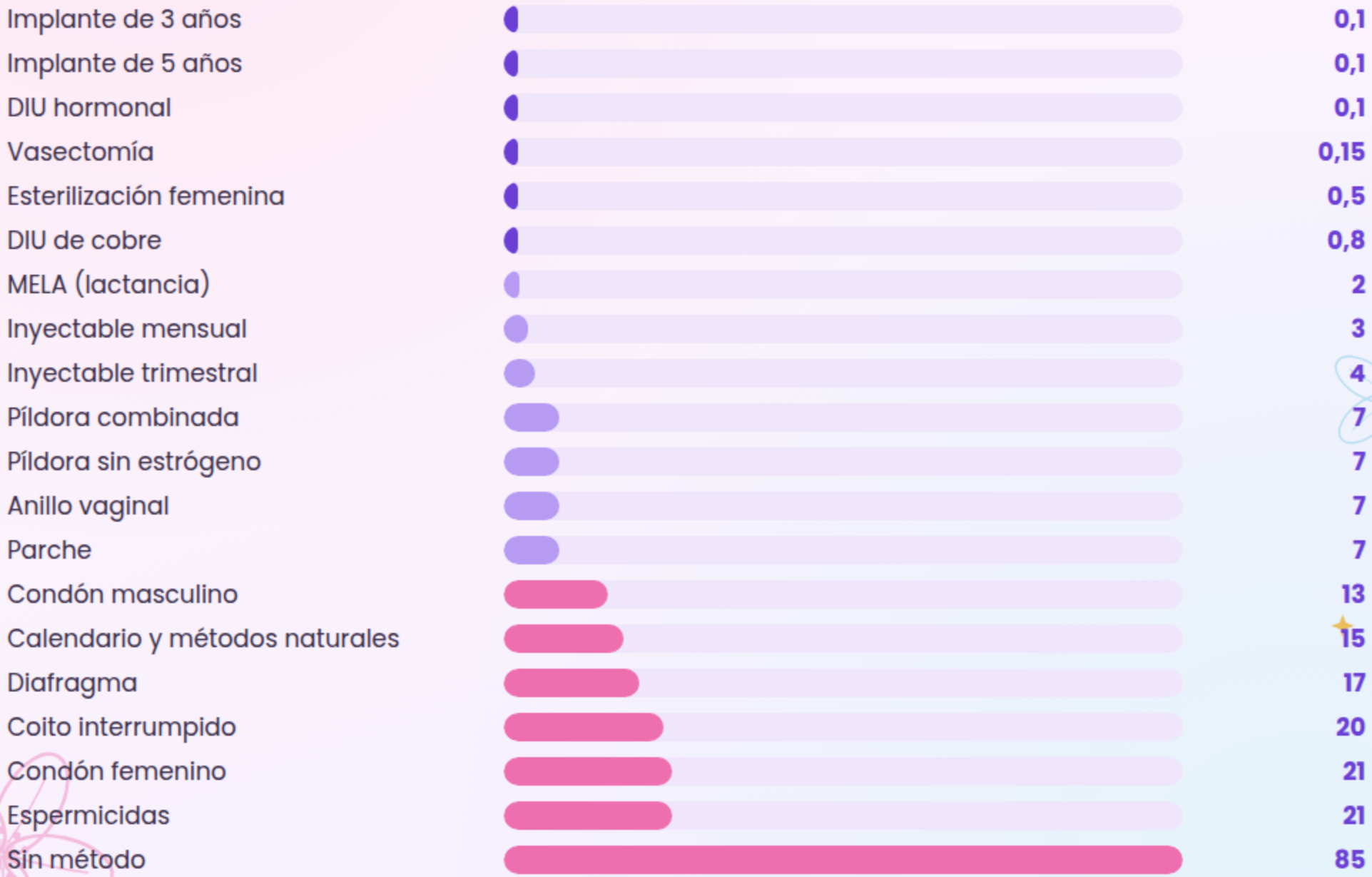
Equivalencias | Fichas por método | Eficacia | Red pública

María Cisterna
MATRONA
Registro Superintendencia de Salud N° 561993

María Cisterna
MATRONA
Registro Superintendencia de Salud N° 561993

Del más al *menos eficaz*

Embarazos por cada 100 mujeres en el primer año, con uso típico (la vida real)



CÓMO LEERLO

Mientras más corta la barra, más eficaz. Los métodos de larga duración (implante y DIU) no dependen de la memoria.

María Cisterna
MATRONA
Registro Superintendencia de Salud N° 561993

Misma fórmula, *otro nombre*

Si tu marca no está, cualquiera de la misma fila tiene la misma hormona y dosis

Levonorgestrel 0,15 mg + EE 0,03 mg	Anulette, Microgynon, Nordette, Norvetal, Innova Cd, Mineva E, Vonille Cd
Levonorgestrel 0,10 mg + EE 0,02 mg	Anulette 20 Cd, Norvetal 20 Cd
Desogestrel 0,15 mg + EE 0,03 mg	Ciclidon, Marvelon, Soluna E
Desogestrel 0,15 mg + EE 0,02 mg	Ciclidon 20 Cd, Marvelon 20, Soluna E20, Gynostat 20, Dal, Miniestrel-20
Gestodeno 0,075 mg + EE 0,03 mg	Ciclomex Cd, Feminol, Prenal, Minulet, Támisa 30/75
Gestodeno 0,075 mg + EE 0,02 mg	Ciclomex 20 Cd, Feminol 20, Prenal 20, Gynera 75/20, Microgen 20, Támisa 20/75, Ginesse
Gestodeno 0,060 mg + EE 0,015 mg	Careza 15, Feminol 15, Juvenex

María Cisterna
MATRONA
Registro Superintendencia de Salud N° 561993

Misma fórmula, *otro nombre*

EE = etinilestradiol (el estrógeno de la mayoría de las píldoras)

Drospirenona 3 mg + EE 0,03 mg	Yasmin, Femelle, Ladee, Vexa Cd, Ladygex, Dahlia, Miafem, Femiplus Cd, Rosina Cd
Drospirenona 3 mg + EE 0,02 mg	Yaz, Femelle 20, Ladee 20, Vexa 20, Dahlia 20, Miafem 20, Ladygex 20, Jolian, Femiplus 20 Cd, Drospera 20
Dienogest 2 mg + EE 0,03 mg	Acotol, Tinelle, Nicol, Norah, Sibilla, Gianda, Daniele, Ginodiest
Clormadinona 2 mg + EE 0,03 mg	Belara, Belara Cd, Viora, Viora Cd
Clormadinona 2 mg + EE 0,02 mg	Gynorelle, Evafem 20, Viora 20, Serenata 20
Nomegestrol 2,5 mg + estradiol 1,5 mg	Zoely, Marilow, Poem Fem, Ariana, Naturel
Ciproterona 2 mg + EE 0,035 mg *	Diane 35, Dixi 35, Anuar, Evilin, Lady Ten 35, Sop, Flarina 35
Valerato de estradiol + dienogest	Qlaira
Estetrol 14,2 mg + drospirenona 3 mg	Drovelis

* Ciproterona: indicada sobre todo para acné o vello; tiene más riesgo de trombosis.

María Cisterna
MATRONA
Registro Superintendencia de Salud N° 561993

Sin estrógeno y de *larga duración*

Desogestrel 0,075 mg	Cerazette, Arlette 28, Lactafem, Nogesta, Soluna, Tejania, Miranda
Drospirenona 4 mg (24+4)	Slinda
Etonogestrel 68 mg · implante 3 años	Implanon NXT
Levonorgestrel 2 × 75 mg · implante 5 años	Jadelle
Levonorgestrel 52 mg · DIU hasta 8 años	Mirena, Asertia, Levosert 2
Levonorgestrel 19,5 mg · DIU 5 años	Kyleena
Medroxiprogesterona trimestral · 150 mg o 104 mg subcutánea	Medroxel, Sayana Press

María Cisterna
MATRONA
Registro Superintendencia de Salud N° 561993

Inyectable, anillo, parche *y emergencia*

Inyectable mensual combinado	Mesigyna, Cyclofemina
Anillo vaginal (etonogestrel + EE)	NuvaRing, Exelring, Esmartia
Parche (norelgestromina + EE)	Evra
Emergencia · levonorgestrel 1,5 mg	Escapel, Cerciora T, Momentum, Evitta-1, Days

RECUERDA

La píldora de emergencia es gratuita en la red pública y en urgencias (Ley 20.418). No es abortiva.

OJO CON LA CONFUSIÓN

María Cisterna
MATRONA
Registro Superintendencia de Salud N° 561993

Estos *no son* anticonceptivos

Aparecen en tablas de equivalencias, pero son tratamientos hormonales: no evitan el embarazo

Dienogest 2 mg	Alondra, Dalgiet · tratamiento de endometriosis
Tibolona 2,5 mg	Tinox, Tobe, Livial, Lirex, Reduclim · menopausia
Estradiol 2 mg	Primaquin 2 mg, Progynova · terapia hormonal
Estradiol 1 mg	Primaquin 1 mg, Cyclobiol · terapia hormonal
Dienogest 2 mg + estradiol 2 mg	Valerix · terapia hormonal
Dienogest 2 mg + estradiol 1 mg	Donabel 2/1 · terapia hormonal

CONSEJO

Si usas alguno de estos y no quieres embarazarte, consulta con tu matrona por un método anticonceptivo.

FICHA DE MÉTODO

María Cisterna
MATRONA
Registro Superintendencia de Salud N° 561993

Implante de 3 años

Implanon NXT · 1 varilla



0,1 embarazos de cada 100 al año (uso típico)

Ventajas

- ✓ Dura 3 años (la ficha chilena permite hasta 5)
- ✓ Una sola varilla: se pone y se saca rápido
- ✓ No depende de la memoria
- ✓ Sirve en lactancia y adolescentes

Desventajas

- – Sangrado irregular (lo más frecuente, no es peligroso)
- – Va bajo la piel (subdérmico) en la cara interna del brazo, 8 a 10 cm sobre el codo y sobre el tríceps; lo pone una matrona o médico
- – No protege de ITS

Riesgos

- ! Sin aumento claro de trombosis
- ! Pequeño aumento de cáncer de mama, similar a otros hormonales

HORMONA

Etonogestrel 68 mg (progestina sola)

RED PÚBLICA

Sí, en APS según disponibilidad

FICHA DE MÉTODO

María Cisterna
MATRONA
Registro Superintendencia de Salud N° 561993

Implante de 5 años

Jadelle · 2 varillas



0,1 embarazos de cada 100 al año (uso típico)

Ventajas

- ✓ Dura 5 años
- ✓ No depende de la memoria
- ✓ Sirve en lactancia y adolescentes
- ✓ La fertilidad vuelve rápido al retirarlo

Desventajas

- – Sangrado irregular (lo más frecuente, no es peligroso)
- – Va bajo la piel (subdérmico) en la cara interna del brazo, 8 a 10 cm sobre el codo y sobre el tríceps; lo pone una matrona o médico
- – Son 2 varillas: la inserción y el retiro toman un poco más
- – Su eficacia puede bajar en personas con peso alto en los últimos años de uso

Riesgos

- ! Sin aumento claro de trombosis
- ! Pequeño aumento de cáncer de mama, similar a otros hormonales

HORMONA
Levonorgestrel 2 × 75 mg (progestina sola)

RED PÚBLICA
Sí, en APS según disponibilidad

FICHA DE MÉTODO

María Cisterna
MATRONA
Registro Superintendencia de Salud N° 561993

DIU hormonal

Mirena · Asertia · Levosert · Kyleena



0,1 embarazos de cada 100 al año (uso típico)

Ventajas

- ✓ Dura 5 a 8 años
- ✓ Disminuye mucho la regla y el dolor
- ✓ Actúa sobre todo dentro del útero

Desventajas

- – Puede doler al insertarlo
- – Sangrado irregular los primeros meses
- – Puede salirse (poco frecuente)
- – No protege de ITS

Riesgos

- ! Sin aumento claro de trombosis
- ! Pequeño aumento de cáncer de mama, similar a otros hormonales

HORMONA
Levonorgestrel (sin estrógeno)

RED PÚBLICA
Según programa local; si no, farmacia

FICHA DE MÉTODO

María Cisterna
MATRONA
Registro Superintendencia de Salud N° 561993

Vasectomía

Corte de los conductos deferentes



0,15 embarazos de cada 100 al año (uso típico)

Ventajas

- ✓ La más eficaz de todas
- ✓ Ambulatoria, con anestesia local, en unos 20 minutos
- ✓ No cambia la erección, el deseo ni la eyaculación
- ✓ Recuperación en pocos días

Desventajas

- – No es inmediata: se usa otro método hasta que el espermiograma salga en cero (unos 3 meses)
- – Revertirla es difícil
- – No protege de ITS

Riesgos

- ! Dolor o hematoma leve los primeros días
- ! Muy rara vez dolor crónico

HORMONA

Sin hormonas

RED PÚBLICA

Sí, en la red pública a solicitud de la persona (Ley 20.418)

FICHA DE MÉTODO

María Cisterna
MATRONA
Registro Superintendencia de Salud N° 561993

Esterilización femenina

Ligadura o salpingectomía (sacar las trompas)



0,5 embarazos de cada 100 al año (uso típico)

Ventajas

- ✓ Definitiva y muy eficaz
- ✓ No hay que acordarse de nada
- ✓ No cambia las hormonas ni la regla
- ✓ Sacar las trompas (salpingectomía) además baja el riesgo de cáncer de ovario

Desventajas

- – Es una cirugía (laparoscopía o junto a una cesárea)
- – Revertirla es difícil y no siempre funciona
- – No protege de ITS

Riesgos

- ! Los propios de una cirugía con anestesia (bajos)
- ! Si falla, mayor riesgo de embarazo ectópico

HORMONA

Sin hormonas

RED PÚBLICA

Sí, en la red pública a solicitud de la persona (Ley 20.418), desde los 18 años

FICHA DE MÉTODO

María Cisterna
MATRONA
Registro Superintendencia de Salud N° 561993

DIU de cobre

T de cobre 380A



0,8 embarazos de cada 100 al año (uso típico)

Ventajas

- ✓ Dura 10 a 12 años
- ✓ Sin hormonas
- ✓ Sirve como emergencia hasta 5 días después

Desventajas

- – La regla puede ser más abundante y dolorosa
- – Lo inserta una matrona o médico
- – No protege de ITS

Riesgos

- ! Expulsión poco frecuente
- ! Perforación del útero muy rara (1 en 1.000)

HORMONA
Sin hormonas

RED PÚBLICA
Sí, en APS

FICHA DE MÉTODO

María Cisterna
MATRONA
Registro Superintendencia de Salud N° 561993

MELA (lactancia)

Método de la lactancia y amenorrea



2 embarazos de cada 100 al año (uso típico)

Ventajas

- ✓ Natural y gratis
- ✓ Sin hormonas
- ✓ Protege mucho si se cumplen las 3 condiciones
- ✓ Favorece la lactancia

Desventajas

- – Solo sirve los primeros 6 meses
- – Hay que cumplir las 3 condiciones a la vez
- – Si una falla, hay que usar otro método
- – No protege de ITS

Riesgos

- ! Ninguno para la salud

HORMONA

Sin hormonas

RED PÚBLICA

Sí: consejería de la matrona en el control posparto

FICHA DE MÉTODO

María Cisterna
MATRONA
Registro Superintendencia de Salud N° 561993

Inyectable mensual

Mesigyna · Cyclofemina



3 embarazos de cada 100 al año (uso típico)

⚠ Tiene estrógeno: más riesgo de trombosis. No usar con migraña con aura, presión alta, trombosis previa ni si fumas y tienes 35+.

Ventajas

- ✓ Una inyección al mes
- ✓ Sangrado regular
- ✓ Discreto

Desventajas

- – Ir a inyectarse cada mes
- – Tiene estrógeno: no sirve para todas
- – No protege de ITS

Riesgos

- ! Mismas precauciones que la píldora combinada
- ! Pequeño aumento de cáncer de mama mientras se usa

HORMONA
Progestina + estrógeno

RED PÚBLICA
Sí, en APS

FICHA DE MÉTODO

María Cisterna
MATRONA
Registro Superintendencia de Salud N° 561993

Inyectable trimestral

Medroxel · Sayana Press



4 embarazos de cada 100 al año (uso típico)

Ventajas

- ✓ Una inyección cada 3 meses
- ✓ Muchas dejan de menstruar (no es dañino)
- ✓ Sirve si no puedes usar estrógeno

Desventajas

- – Sangrado irregular
- – La fertilidad tarda hasta 10 meses en volver
- – Puede subir de peso

Riesgos

- ! Baja la densidad ósea mientras se usa (se recupera)
- ! Posible aumento de trombosis (CDC 2024)

HORMONA
Medroxiprogesterona (sin estrógeno)

RED PÚBLICA
Sí, en APS

María Cisterna
MATRONA
Registro Superintendencia de Salud N° 561993

Píldora combinada



Yasmin · Yaz · Microgynon · Belara · Zoely · Qlaira · Drovelis y más

7 embarazos de cada 100 al año (uso típico)

⚠ Tiene estrógeno: más riesgo de trombosis. No usar con migraña con aura, presión alta, trombosis previa ni si fumas y tienes 35+.

Ventajas

- ✓ Ciclos regulares y menos dolor
- ✓ Mejora el acné
- ✓ Protege contra cáncer de endometrio y ovario

Desventajas

- – Tomarla todos los días a la misma hora
- – Al inicio: náuseas o sensibilidad mamaria
- – No protege de ITS

Riesgos

- ! Trombosis: 3 a 12 por 10.000 al año según la progestina (en el embarazo es mayor)
- ! No usar: migraña con aura, 35+ y fumas, presión alta, antecedente de trombosis

HORMONA

Estrógeno (etinilestradiol o estradiol) + progestina: drospirenona, levonorgestrel, desogestrel, gestodeno, dienogest, clormadinona o nomegestrol

RED PÚBLICA

Sí, levonorgestrel + EE en APS

FICHA DE MÉTODO

María Cisterna
MATRONA
Registro Superintendencia de Salud N° 561993

Píldora sin estrógeno

Cerazette · Slinda y equivalentes



7 embarazos de cada 100 al año (uso típico)

Ventajas

- ✓ Sirve en lactancia
- ✓ Sirve si no puedes usar estrógeno (migraña con aura, hipertensión, fumadora 35+)
- ✓ Slinda: 24 h de margen de olvido

Desventajas

- – Tomarla todos los días
- – Sangrado irregular
- – No protege de ITS

Riesgos

- ! Sin aumento claro de trombosis

HORMONA

Progestina sola: desogestrel (Cerazette) o drospirenona sola (Slinda)

RED PÚBLICA

Desogestrel sí, en APS · Slinda en farmacia

FICHA DE MÉTODO

María Cisterna
MATRONA
Registro Superintendencia de Salud N° 561993

Anillo vaginal

NuvaRing · Exelring · Esmartia



7 embarazos de cada 100 al año (uso típico)

⚠ Tiene estrógeno: más riesgo de trombosis. No usar con migraña con aura, presión alta, trombosis previa ni si fumas y tienes 35+.

Ventajas

- ✓ Uno al mes: no hay que acordarse cada día
- ✓ Ciclos regulares
- ✓ Protege contra cáncer de endometrio y ovario

Desventajas

- – Molestia o más flujo vaginal
- – Puede salirse
- – No protege de ITS

Riesgos

- ! Trombosis: 6 a 12 por 10.000 mujeres al año
- ! No usar con migraña con aura o si fumas y tienes 35+

HORMONA
Etonogestrel + etinilestradiol

RED PÚBLICA
Farmacia

FICHA DE MÉTODO

María Cisterna
MATRONA
Registro Superintendencia de Salud N° 561993

Parche

Evra



7 embarazos de cada 100 al año (uso típico)

⚠ Tiene estrógeno: más riesgo de trombosis. No usar con migraña con aura, presión alta, trombosis previa ni si fumas y tienes 35+.

Ventajas

- ✓ Uno a la semana
- ✓ Ciclos regulares
- ✓ Fácil de usar

Desventajas

- – Puede irritar la piel o despegarse
- – Menos eficaz con 90 kg o más
- – No protege de ITS

Riesgos

- ! Trombosis: 6 a 12 por 10.000 mujeres al año
- ! No usar con migraña con aura o si fumas y tienes 35+

HORMONA

Norelgestromina + etinilestradiol

RED PÚBLICA

Farmacia

FICHA DE MÉTODO

María Cisterna
MATRONA
Registro Superintendencia de Salud N° 561993

Condón masculino

Látex o poliuretano · gratis en APS



13 embarazos de cada 100 al año (uso típico)

Ventajas

- ✓ El único que también protege de ITS y VIH
- ✓ Sin hormonas
- ✓ Fácil de conseguir

Desventajas

- – Usarlo bien en cada relación
- – Se puede romper o salir

Riesgos

- ! Alergia al látex (hay sin látex)

HORMONA
Sin hormonas

RED PÚBLICA
Sí, gratis en APS

FICHA DE MÉTODO

María Cisterna
MATRONA
Registro Superintendencia de Salud N° 561993

Calendario y métodos naturales

Ritmo, días fijos, Billings, temperatura



2 a 23 embarazos de cada 100 al año (uso típico)

Ventajas

- ✓ Sin hormonas ni costo
- ✓ Ayuda a conocer el propio ciclo
- ✓ Aceptado por todas las creencias

Desventajas

- – Fallan mucho con uso típico: 2 a 23 de cada 100 al año
- – Requieren ciclos regulares y registro diario
- – Hay que evitar relaciones o usar condón varios días al mes
- – No sirven bien en adolescentes, posparto, lactancia ni perimenopausia

Riesgos

- ! Ninguno para la salud; el riesgo es el embarazo no planificado

HORMONA
Sin hormonas

RED PÚBLICA
Sí: consejería de la matrona

FICHA DE MÉTODO

María Cisterna
MATRONA
Registro Superintendencia de Salud N° 561993

Diafragma

Copa de silicona + espermicida



17 embarazos de cada 100 al año (uso típico)

Ventajas

- ✓ Sin hormonas
- ✓ Se pone solo cuando se va a usar
- ✓ Reutilizable por 1 a 2 años

Desventajas

- – Hay que ponerlo antes de la relación y dejarlo 6 horas después
- – Se usa con espermicida
- – Requiere práctica y a veces medición
- – Poca disponibilidad en Chile

Riesgos

- ! Más infecciones urinarias en algunas mujeres
- ! Muy raro: síndrome de shock tóxico si se deja más de 24 horas

HORMONA
Sin hormonas

RED PÚBLICA
No; casi no se encuentra en Chile

FICHA DE MÉTODO

María Cisterna
MATRONA
Registro Superintendencia de Salud N° 561993

Coito interrumpido

Retirar el pene antes de eyacular

20 embarazos de cada 100 al año (uso típico)

Ventajas

- ✓ Sin costo ni hormonas
- ✓ Siempre disponible

Desventajas

- – Falla mucho: 20 de cada 100 al año
- – El líquido previo puede tener espermatozoides
- – Depende del control de la pareja
- – No protege de ITS

Riesgos

! Ninguno para la salud; el riesgo es el embarazo no planificado

HORMONA

Sin hormonas

RED PÚBLICA

No es un insumo: consejería de la matrona

FICHA DE MÉTODO

María Cisterna
MATRONA
Registro Superintendencia de Salud N° 561993

Condón femenino

Condón interno de nitrilo



21 embarazos de cada 100 al año (uso típico)

Ventajas

- ✓ Lo controla la mujer y se puede poner hasta 8 horas antes
- ✓ Protege de ITS y del embarazo
- ✓ Sirve si hay alergia al látex
- ✓ Sin hormonas

Desventajas

- – Al comienzo cuesta ponerlo: hay que practicar
- – Puede hacer ruido o moverse
- – Es de un solo uso y es más caro
- – No usar junto con el condón masculino (se rompen por roce)

Riesgos

! Prácticamente ninguno; rara vez irritación

HORMONA

Sin hormonas

RED PÚBLICA

Según disponibilidad en APS y programas de ITS

FICHA DE MÉTODO

María Cisterna
MATRONA
Registro Superintendencia de Salud N° 561993

Espermicidas

Gel, óvulo o espuma vaginal



21 embarazos de cada 100 al año (uso típico)

Ventajas

- ✓ Sin hormonas
- ✓ Se compran sin receta
- ✓ Aumentan la eficacia del diafragma o del condón

Desventajas

- – Solos fallan mucho: 21 de cada 100 al año
- – Hay que ponerlos 10 a 15 minutos antes y repetir en cada relación
- – Pueden irritar la vagina
- – No protegen de ITS

Riesgos

- ! El nonoxinol-9 usado muchas veces al día puede irritar y AUMENTAR el riesgo de VIH: no usar si hay riesgo de VIH

HORMONA

Sin hormonas

RED PÚBLICA

No; casi no se encuentran en farmacias chilenas

FICHA DE MÉTODO

María Cisterna
MATRONA
Registro Superintendencia de Salud N° 561993

Píldora de emergencia

Escapel · Postinor 2 · Postday · Momentum



Emergencia hasta 72 horas después

Ventajas

- ✓ Mientras antes, mejor: hasta 72 horas
- ✓ No es abortiva
- ✓ Se puede usar cualquier día del ciclo

Desventajas

- – Solo para emergencias
- – Puede adelantar o atrasar la regla
- – No protege en relaciones posteriores
- – Con peso alto (más de 70 kg o IMC sobre 26) puede ser menos eficaz: el DIU de cobre es la opción más eficaz

Riesgos

- ! Sin riesgo demostrado de trombosis ni cáncer

HORMONA
Levonorgestrel 1,5 mg

RED PÚBLICA
Sí, gratis en APS y urgencias (Ley 20.418)

María Cisterna
MATRONA
Registro Superintendencia de Salud N° 561993

Terapia hormonal de la *menopausia*

No es anticonceptivo: alivia síntomas desde la perimenopausia

1 · Local vaginal

- Estriol en gel u óvulos para sequedad, ardor y dolor en la relación
- Dosis muy baja: no necesita progestágeno, aunque tengas útero

2 · Sistémica

- Para bochornos, sueño y ánimo
- Con útero: estrógeno + progestágeno o DIU con levonorgestrel (protege el endometrio)
- Sin útero: estrógeno solo

Fitoestrógenos

- Soya y linaza: efecto leve en bochornos
- No reemplazan la terapia si los síntomas son intensos

Andropausia

- En hombres la testosterona baja de a poco
- Se evalúa con urología o medicina, con exámenes

OJO

En la perimenopausia todavía puedes embarazarte: sigue con un método hasta 1 año sin regla (2 años si tienes menos de 50).

Fuentes y *créditos*

- MINSAL. Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad.
- Ley 20.418 sobre información, orientación y prestaciones en regulación de la fertilidad.
- OMS. Criterios médicos de elegibilidad, 6.ª ed. (2025) y Manual de planificación familiar (2022).
- CDC. U.S. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use (2024).
- Trussell J. Contraceptive failure (2018).
- Marcas: catálogos de farmacias chilenas.

AUTORA

María Cisterna Escobar, matrona · Registro Superintendencia de Salud N° 561993. Material educativo: no reemplaza la consulta con tu matrona.